EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN EN SALUD BUCO DENTAL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La salud bucodental es parte integral de la salud general, entendida como el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (Organización Mundial de la Salud [OMS], s.f.). Actualmente, la ausencia de salud bucodental es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que casi la mitad de población (3,5 mil millones de personas), padece enfermedades bucodentales; de estas, tres de cada cuatro viven en países de ingreso bajo y mediano y esta asociación se da desde la niñez hasta la vejez. Por otra parte, el problema se agrava por el incremento en unos mil millones durante los últimos 30 años, evidenciando una limitación de acceso a la prevención y el tratamiento de las enfermedades bucodentales (OMS, 2022). La Organización Mundial de la Salud (OMS), en la Asamblea Mundial del 2021 aprobó estrategias que se centran en la promoción. Así mismo, en el 2022 se adoptó la estrategia mundial sobre salud bucodental, cuya visión es la cobertura sanitaria universal para la salud bucodental de todas las personas y comunidades para 2030, priorizando las poblaciones marginadas y de bajos ingresos, con más limitaciones para acceder a la atención; entre dichas estrategias se incluyen el fortalecimiento de la prevención y la atención primaria de salud centrada en el paciente (OMS, 2022). El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (actual director general de la OMS), declaró que “durante largo tiempo se ha descuidado la salud bucodental como parte de la salud mundial, pero muchas enfermedades bucodentales pueden prevenirse y ser tratadas con las medidas costo eficaces”. Y que la OMS tiene el compromiso de “facilitar orientación y apoyo a los países, de modo que todas las personas, independientemente de su lugar de residencia y de cualesquiera que sean sus ingresos, dispongan del conocimiento y las herramientas precisas para cuidar sus dientes y su boca, así como para acceder a los servicios de prevención y atención cuando los necesiten” (OMS, 2022). Las enfermedades bucodentales más frecuentes son: la caries dental, la periodontitis grave, la pérdida de dientes y el cáncer bucal. La caries dental no tratada es la afección con mayor prevalencia a nivel mundial y se estima que afecta a 2 500 millones de personas. Se calcula que la periodontitis grave, es una de las causas principales de la pérdida dental total, afecta a mil millones de personas en todo el mundo y cada año se diagnostican unos 380 000 nuevos casos de cáncer bucal (OMS, 2022). La periodontitis es la enfermedad crónica inflamatoria más común que se observa en humanos, y afecta a casi la mitad de los adultos en el Reino Unido y en Estados Unidos y al 60 % de los mayores de 65 años. Es un importante problema de salud pública, causando pérdida de dientes, discapacidad, disfunción masticatoria y estado nutricional deficiente. La periodontitis también compromete el habla, reduce la calidad de la vida y es una carga creciente para la economía. Las enfermedades periodontales son muy prevalentes, tienden a afectar considerablemente a los individuos y a la sociedad, su tratamiento es costoso y son, en su gran mayoría, prevenibles, existiendo métodos eficaces para controlarlas (Carvajal, 2016). Mientras que, en Costa Rica, se ha evidenciado que el problema progresa desde la niñez,

	ya que las cifras demuestran que el 47 % de los casos, mantienen su condición dental sin historia de caries, situación que se deteriora durante el ciclo de vida de las personas, hasta que se llega a tener un promedio de cuatro a seis dientes, de los cuales ninguno se encuentra sano. Más aún, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), para el "2050 la cuarta parte de la población tendrá 60 años o más y requerirá de algún tipo de prótesis dental y una respuesta oportuna en la atención de los servicios odontológicos" (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2004). Aunado a esto, los hábitos de higiene de la población manifiestan deterioro, lo que guarda relación directa con la pérdida de dientes a edad temprana. Así como, "el bajo impacto de los servicios de atención de la salud bucodental del país y la falta de integración de estos contribuye a que la población no mantenga altos índices de salud bucodental durante su ciclo de vida. Siendo causa de ello el reducido acceso universal y equitativo de la población a los servicios de promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud bucal, en el curso de vida, lo que se manifiesta en: barreras en la cobertura y accesibilidad de la atención de la salud bucal a escala nacional, sin enfoque de atención primaria. Recursos humanos insuficientes en los servicios de salud odontológicos en cantidad. Insuficiente producción y gestión del conocimiento e investigación" (CCSS, 2004). Las Prestaciones Odontológicas de la Caja Costarricense de Seguro Social se orientan en: promoción con participación social, prevención masiva y específica, actividades clínicas (preventivas, curativas y rehabilitación) (CCSS, 2004). Según el instrumento de gestión de los servicios de odontología de la CCSS en el 2019, se logró abarcar el 17,4 % de la población total asegurada, con un odontólogo por cada 11 362 habitantes (cuando debería ser de uno cada 5000). Un estudio realizado en el 2016 identificó que el 71,2 % de las personas adultas mayores que asistieron al servicio de odontología de la CCSS requieren algún tipo de prótesis dental y 25,0 % son totalmente edéntulas (CCSS, 2004). El marco jurídico nacional relacionado con la atención odontológica en el país es el siguiente: • Ley general de salud Nº 5395 (1973). Se establece el derecho a las prestaciones de la salud de la población y se menciona el acceso a exámenes dentales preventivos en escolares. • Ley orgánica del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica Nº 5784 (1975), artículo 4. • Ley del servicio social obligatorio para los profesionales en las ciencias de la salud Nº 7559 (1985).
Evidencia	Las estrategias de educación sobre salud bucal dirigidas por dentistas, docentes y pares son igualmente efectivas para mejorar el conocimiento sobre salud bucal y el estado de higiene bucal de los adolescentes. Sin embargo, la estrategia dirigida por pares es casi tan efectiva como la estrategia dirigida por el dentista y comparativamente más efectiva que las estrategias dirigidas por el maestro y las de autoaprendizaje para mejorar su comportamiento de salud bucal (Haleem et al., 2012). Los resultados del Estudio Multicéntrico en Latinoamérica de Nutrición y Salud (ELANS), publicado en el año 2018 en la revista "Nutrients", revelaron que el 80 % de las personas adultas costarricenses consumen más del 10 % del total de energía derivada de los azúcares agregados, lo cual supera la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Lo anterior es preocupante ya que, la reducción de su consumo como parte de una dieta saludable ayuda a disminuir la caries, la diabetes, la obesidad y otras enfermedades

	no transmisibles (ENT). La Política Nacional de Salud establece que todo escolar deberá someterse a los exámenes dentales preventivos, participar en los programas educativos sobre salud que deberán ofrecer los centros educativos tanto públicos como privados. Por otra parte, algunos de los actuales objetivos de la Política Nacional de Salud Bucal incluyen el subsanar las desigualdades sanitarias dentro de una estrategia integral que tome en cuenta los factores de riesgo comunes y los determinantes fundamentales de la salud, esto basado en la promoción de una mejor salud bucal (Ministerio de Salud [MINSA], 2022). Por su parte, la última Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 evidenció en sus resultados que en el grupo entre 1-6 años el promedio de piezas dentales cariadas, extraídas y obturadas es de 2,2; siendo los dientes cariados la mayor cantidad, especialmente en la zona rural, lo que evidencia problemas de acceso a prevención y tratamiento. En la población de siete a 12 años se mostró que la severidad de piezas dentales cariadas, perdidas y obturadas fue de 1,43, a expensas de que las piezas obturadas representan la mayoría, siendo ambas condiciones totalmente prevenibles (MINSA, 2022). La implementación de políticas de promoción y prevención de la salud bucodental desde temprana edad permiten lograr niveles ideales a la edad de 12 años y estos se podrían mantener estables a través de toda la vida del individuo. Esto justifica ampliamente la aplicación de medidas preventivas como la educación en salud oral, la detección, valoración y control de placa bacteriana en la población preescolar, de manera que se han creado objetivos y estrategias donde la CCSS como parte de sector salud esta implícita (MINSA, 2022).
Consideraciones de Implementación	<u>Limitaciones</u>: En lugares donde no existe señal para conectarse al internet no se puede llenar información en EDUS. Eventualidades en el EDUS que no permitan verificar si el paciente consulta de primera vez o subsecuente hace que se incrementen en forma irreal las coberturas porque se ingresan como de primera vez. <u>Estrategias</u>: Para solventar esta situación se registra en físico y en la sede del área o su lugar de trabajo se ingresan a EDUS.
Normativa Técnica	• Norma de prestaciones odontológicas (1997). CCSS. • Norma para la atención preventiva en salud oral CEN-CINAI (2014) (PS.DN.UNAT.AID.ODONT. N.01) • Protocolos para la atención clínica en red específicos de la CCSS: trastornos temporomandibulares y dolor orofacial (2019). • Protocolos para la atención clínica en red específicos de la CCSS: operatoria dental, cirugía ortognática, ortopedia funcional correctiva, interceptiva y preventiva, cirugía oral menor mayor y maxilofacial y periodoncia (2020). • Instrucción de trabajo para regreso ordinario en los servicios de odontología de los tres niveles de atención de la CCSS" (2022), código IT.GM.DDSS. ARSDT.OD.21112022.
Costo / Efectividad	Evaluando la efectividad clínica y la rentabilidad de los programas de promoción de la salud bucal, para reducir los dientes cariados, perdidos u obturados (CPOD) y al mismo tiempo reducir el costo financiero para las instituciones de salud, se verificaron revisiones sistemáticas y metaanálisis (PRISMA), lo que demostró eficacia para reducir el costo y confirmó un efecto de reducción en el CPOD infantil. (Fraihat et al., 2019). Se realizaron dos intervenciones, una con acciones básicas educativo-preventivas-

	curativas masivas (IMCCD) y otra con acciones intensivas según el grado de riesgo (IRCCD). Se analizó el costo-efectividad para estas alternativas. La IRCCD fue la alternativa más efectiva en la prevención de la caries dental con 95 % de casos prevenidos/año y la menos costosa en total con $ 1 824 (costo promedio de $ 8,4 paciente/año). El menor costo y el mayor número de casos prevenidos en la IRCCD, la hicieron más eficiente con un costo de $ 8,8 dólares por caso prevenido/año (Gispert et al., 2015).
Objetivo (s) de la Evaluación	Determinar el porcentaje de personas que tienen acceso a los servicios de odontología, a los cuales se les brinda atención preventiva y curativa, para fomentar la salud bucodental y disminuir el riesgo de múltiples enfermedades sistémicas
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es la variación interanual en la cobertura de atención de personas atendidas en odontología del primer nivel de atención en salud? ¿Cuál es el porcentaje de personas atendidas en odontología del primer nivel de atención que recibe educación en salud bucodental y acciones de prevención de las enfermedades bucodentales? ¿Cuál es el estado y progresión de la enfermedad dental en las personas que consultan en el primer nivel de atención en salud?
Indicadores asociados a la intervención	02-01-1.0 Cobertura de atención en salud oral a personas de 20 años a 64 años, en el primer nivel de atención. 02-02-1.0 Cobertura de atención en salud oral a personas de 65 años y más en el primer nivel de atención. 02-03-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 0 a 9 años, en el primer nivel de atención. 02-04-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 10 a 19 años, en el primer nivel de atención. 02-05-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 20 a 64 años, en el primer nivel de atención. 02-06-1.0 Porcentaje de atenciones en salud oral con educación preventiva en Odontología en personas de 65 años y más en el primer nivel de atención.
Anexos	Manual del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Odontología (2022). Actualización IT.GM.DDSS. ARSDT-OD-200720 Versión 02.
Referencias Bibliográficas	Anstey, E., Bradley, C., Shimbo, D. (2021). USPSTF Recommendation Statement on Hypertension Screening in Adults—Where Do We Go From Here? *JAMA Netw Open*, *4*(4). doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.4203 Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2004). Plan Nacional de Atención en Salud Bucodental. San José. Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2018). Plan Estratégico Institucional 2019-2022. CENDEISSS. https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2020/02/PLAN-ESTRATÉGICO-INSTITUCIONAL-2019-2022.pdf Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2021). Vigilancia de los Factores de Riesgo Cardiovascular, tercera encuesta 2018. San Jose: EDNASS-CCSS.

Carvajal, P. (2016). Enfermedades periodontales como un problema de salud pública: el desafío del nivel primario de atención en salud. *Revista clínica de periodoncia, implantología y rehabilitación oral*, *9*(2), 177-183. https://dx.doi.org/10.1016/j.piro.2016.07.001

Castro, L. P., Soria, I. C., Casco, E. C., & Vallejo, M. D. (2016). Análisis de costo-efectividad e impacto presupuestal de un programa de atención farmacéutica para pacientes hipertensos de un hospital de tercer nivel de México. *Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas*, 25.

Fraihat, N., Madae'en, S., Bencze, Z., Herczeg, A., & Varga, O. (2019). Clinical Effectiveness and Cost-Effectiveness of Oral-Health Promotion in Dental Caries Prevention among Children: Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16*(15), 2668. https://doi.org/10.3390/ijerph16152668

Gispert, E., Collazo, M., & Sosa, I. (2015). Evaluación económica de dos intervenciones para el control de caries dental en escolares de primaria en Cuba. *Ciencia Odontológica*, *12*(2). https://produccioncientificaluz.org/index.php/cienciao/article/view/33802

Haleem, A., Siddiqui, M.I. & Khan, A.A. (2012). School-based strategies for oral health education of adolescents- a cluster randomized controlled trial. *BMC Oral Health*, *12*(54). https://doi.org/10.1186/1472-6831-12-54

Hettiarachchi, R. M., Kularatna, S., Downes, M. J., Byrnes, J., Kroon, J., Lalloo, R., Johnson, N. W., & Scuffham, P. A. (2018). The cost-effectiveness of oral health interventions: A systematic review of cost-utility analyses. *Community dentistry and oral epidemiology*, *46*(2), 118–124. https://doi.org/10.1111/cdoe.12336

Ministerio de Salud [MINSA]. (2022). Política Nacional de Salud Bucal 2022-2032. MINSA.

Ministerio de Salud de Costa Rica. (17 de mayo de 2023). *Medí tu presión arterial con precisión, contrólala, viví más*. Ministerio de Salud Gobierno de Costa Rica. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/60-noticias-2023/1592-casos-notificados-de-hipertension-arterial-disminuyen-un-19-6-durante-2022#:~:text=Sin%20embargo%2C%20las%20defunciones%20asociadas,muertes%20asociadas%20a%20esta%20enfermedad.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Directriz para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en adultos. Organización Mundial de la Salud. https://iris.who.int/handle/10665/364491

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (18 de noviembre de 2022). La OMS destaca que el descuido de la salud bucodental afecta a casi la mitad de la población mundial. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news/item/18-11-2022-who-highlights-oral-health-neglect-affecting-nearly-half-of-the-world-s-population

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (21 de agosto de 2023). Hipertensión. OPS. https://www.paho.org/es/temas/hipertension

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (s.f.). La OMS mantiene su firme compromiso con los principios establecidos en el preámbulo de la Constitución https://www.who.int/es/about/governance/constitution

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (15 de marzo de 2022). Salud bucodental. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health

Zhao, J., Shi, H., Wang, J., Huang, R., Liu, Y., Zhang, Y., Jiang, N., Wang, T., Wang, J., Xu, X. (2022). Association of oral health knowledge, self-efficacy and behaviours with oral health-related quality of life in Chinese primary school children: a cross-sectional study. *BMJ Open*, *12*(12). doi: 10.1136/bmjopen-2022-062170